



Périmètre limité : le référentiel SFAR complet (2009-2011) comporte 4 modules distincts (Cardiovasculaire, déjà traité dans une fiche séparée ; Douleur chronique/toxicomanie — cette fiche ; Infectieux/immunosuppresseurs ; Neurologique-psychiatrique et/ou endocrinien). Les 3 autres modules ne sont pas traités ici — disclosed explicitement, à construire séparément.

Grille ANAES 2004 — **A** : preuve scientifique établie ; **B** : présomption scientifique ; **C** : faible niveau de preuve ; **AF** : accord fort (grade D renforcé par méthode Delphi). Fiche limitée au Module 2/4 du référentiel (douleur chronique, toxicomanie) — voir encadré de périmètre ci-dessous. La majorité des énoncés de ce module ne portent aucun grade — voir « repères pratiques non gradés ».

Opioïdes (traitement chronique de la douleur)

Classe	Recommandation	Grade
Opioïdes	Un sevrage ou réajustement thérapeutique ne doit pas être envisagé en période périopératoire — seulement à distance de l'intervention, en période de stabilité et lorsque la douleur a significativement diminué.	C
Opioïdes	Administrer en préopératoire la dose habituelle de morphinique, ou la dose équianalgésique d'un autre opioïde (voie orale ou IV à l'induction).	AF
Opioïdes	Un patch de fentanyl ne doit pas être retiré en périopératoire, sauf substitution par un autre opioïde.	AF
Opioïdes	Les morphiniques de palier 2 (codéine, dextropropoxyphène, tramadol) doivent être poursuivis, voire substitués par un autre opioïde (y compris de palier supérieur) à dose équianalgésique.	AF
Opioïdes	Éviter, hors urgence, les antagonistes/agonistes partiels/antagonistes μ (naloxone, naltrexone, nalbuphine, butorphanol, buprénorphine, pentazocine) chez le patient dépendant aux opioïdes — risque de syndrome de sevrage.	C

DCI	Ratio vs. morphine orale	Équivalence
Dextropropoxyphène	1/6	60 mg = 10 mg morphine
Codéine	1/6	60 mg = 10 mg morphine
Dihydrocodéine	1/3	60 mg = 20 mg morphine
Tramadol	1/5 à 1/6	50-60 mg = 10 mg morphine
Péthidine	1/5	50 mg = 10 mg morphine
Morphine IV	3	1 mg IV = 3 mg morphine orale
Morphine SC/IM	2	1 mg SC = 2 mg morphine orale
Oxycodone orale	2	5 mg = 10 mg morphine orale
Hydromorphone	7,5	4 mg = 30 mg morphine
Buprénorphine SL	30	0,2 mg = 6 mg morphine orale
Fentanyl transdermique	variable	25 μ g/h ~ 60 mg/j morphine

10 mg de morphine IV = 1 mg de morphine péridurale = 0,1 mg de morphine intrathécale.

Analgésiques non morphiniques — AINS et coxibs

Classe	Recommandation	Grade
AINS non sélectifs	Maintien recommandé en périopératoire si les contre-indications sont respectées — SAUF pour les chirurgies à risque hémorragique difficile à contrôler (neurochirurgie intracrânienne, chirurgie urologique, amygdalectomie, chirurgie ophtalmologique hors cataracte, chirurgie orthopédique lourde), où l'arrêt est recommandé.	B



Classe	Recommandation	Grade
Coxibs	Maintien recommandé en périopératoire chez les patients sans facteur de risque cardiovasculaire opérés de chirurgie non cardiaque.	B

Précision du source : absence de recommandation dégagée par la source elle-même sur le risque cardiovasculaire périopératoire des coxibs au long cours (absence d'étude spécifique) ; pas d'arrêt recommandé d'un AINS/coxib avant une ALR périphérique (risque hémorragique très faible/nul). Stratégie d'arrêt pour chirurgie à risque hémorragique : AINS de longue demi-vie (oxicams, naproxène) 7 à 10 jours avant, AINS de demi-vie courte (ibuprofène, kétoprofène, flurbiprofène) 24 heures avant.

Antiépileptiques, antidépresseurs & benzodiazépines (douleur chronique)

Classe	Recommandation	Grade
Antiépileptiques	Poursuivre en périopératoire les traitements prescrits à visée antalgique (clonazépam, carbamazépine, gabapentine, prégabaline).	AF
Antidépresseurs	Poursuivre en périopératoire les traitements prescrits à visée antalgique (tricycliques, IRS, venlafaxine).	AF
Benzodiazépines	Poursuivre en périopératoire les traitements prescrits à visée antalgique (ex. clonazépam pour douleur neuropathique).	AF

Précision du source : la carbamazépine peut diminuer la durée d'action des curares ; la gabapentine en prémédication à dose importante (1200 mg) réduit l'hyperalgésie postopératoire. En cas d'interruption du transit, voie IV possible pour le clonazépam (aucune forme IV pour la gabapentine — sonde gastrique envisageable).

Cathéters intrathécaux/périmédullaires & stimulateurs médullaires

Classe	Recommandation	Grade
Cathéters intrathécaux	Ne pas interrompre la perfusion des dispositifs analgésiques (opiacés, baclofène) tout au long de la période périopératoire, pour éviter un sevrage.	AF
Cathéters intrathécaux	En cas de risque particulier (effets indésirables du baclofène, récurrence de troubles neurologiques à son arrêt), un contact avec le médecin référent est souhaitable pour déterminer la stratégie.	AF
Stimulateur médullaire	Ne pas réaliser d'anesthésie et/ou d'analgésie périmédullaire chez le porteur d'un stimulateur médullaire.	AF
Stimulateur médullaire	Précautions d'utilisation au bloc opératoire identiques à celles des stimulateurs cardiaques (bistouri bipolaire recommandé), en l'absence de données spécifiques.	AF

Précision du source : en cas de tolérance/désensibilisation aux opiacés (cathéter intrathécal au long cours), il est recommandé d'augmenter les posologies de morphiniques (la kétamine pourrait être d'un apport intéressant) ; en cas d'anesthésie axiale, peser les bénéfices/risques (contamination infectieuse du dispositif) et connaître le niveau d'insertion et le trajet du cathéter.



Toxicomanie substituée (méthadone, buprénorphine)

Classe	Recommandation	Grade
Subst. opiacés	Donner oralement, le matin de l'intervention, la dose quotidienne du traitement substitutif, quelle que soit la technique d'anesthésie choisie.	AF
Subst. opiacés	Si la voie orale est impossible, administrer la morphine par voie sous-cutanée ou intraveineuse.	AF
Subst. opiacés	Poursuivre le traitement substitutif tout au long de l'hospitalisation, pour assurer les besoins de base en opiacés et éviter un sevrage.	AF
Subst. opiacés	Favoriser chaque fois que possible une ALR axiale ou périphérique.	AF
Subst. opiacés	Augmenter les doses de morphine prescrites pour l'analgésie postopératoire ; la kétamine pourrait présenter un intérêt chez ces patients tolérants aux opiacés.	C
Subst. opiacés	Les agonistes-antagonistes et antagonistes des récepteurs μ (nalbuphine, butorphanol, pentazocine, naloxone) sont formellement contre-indiqués chez le patient sous traitement substitutif.	C

Précision du source : il est recommandé d'arrêter la naltrexone au minimum 24 à 48 heures avant une intervention (cet antagoniste μ diminue fortement les effets des morphiniques) ; adresser le patient en consultation avec un médecin spécialisé en toxicomanie ; prémédication par benzodiazépine souvent adaptée (codépendance fréquente).

Molécule	Équivalence (ordre de grandeur)
Sulfate de morphine oral	10 mg (référence)
Sulfate de morphine parentéral (IV/SC)	~ 3,3 mg
Méthadone orale	~ 6–7 mg
Buprénorphine	~ 1,2–1,4 mg

Toxicomanie active — cannabis, héroïne, cocaïne, autres substances

Classe	Recommandation	Grade
Cannabis	S'abstenir de fumer ou de consommer du cannabis avant une chirurgie réglée (comme pour le tabac).	AF
Héroïne (active)	Les agonistes-antagonistes et antagonistes μ sont formellement contre-indiqués (risque de syndrome de sevrage aigu).	C
Héroïne (active)	Augmenter fréquemment les doses des médicaments hypnotiques et morphiniques en cas d'anesthésie générale.	C
Cocaïne	En cas d'ALR axiale, demander au minimum un dosage des plaquettes (risque de thrombopénie).	C
Médec. détournés	Risque de crise convulsive lors d'un sevrage des benzodiazépines.	C
Médec. détournés	Il n'est pas recommandé d'administrer des doses plus élevées de morphiniques pour l'anesthésie générale ou l'analgésie postopératoire (absence de tolérance croisée benzodiazépines/morphiniques).	B

Repères pratiques non gradés : la majorité des énoncés prescriptifs de ce module ne portent aucune citation de grade dans le texte source. Conformément à la règle anti-fabrication de grade, ils sont regroupés ci-dessous en repères pratiques par substance, distincts des tableaux de recommandations effectivement gradés.

Cannabis (repères non gradés par la source) : prudence avec les médicaments tachycardisants (kétamine, pancuronium, atropine, éphédrine, adrénaline), éviter l'halothane ; potentialise les effets des opiacés (sommolence, dépression respiratoire).

Héroïne (active) (repères non gradés par la source) : le sevrage en période chirurgicale n'est jamais le bon moment (risque de récurrence) ; établir un contrat de soins explicite avec le patient et l'équipe spécialisée ; substitution le matin de la chirurgie par une dose équivalente de morphine orale ; en urgence, considérer le patient comme estomac plein et réaliser une induction en séquence rapide.



Cocaïne (*repères non gradés par la source*) : sevrage complet d'au moins une semaine avant une intervention programmée (un sevrage plus court ne protège pas des complications) ; éviter étomidate, kétamine et halothane en cas d'anesthésie générale ; bêtabloquants contre-indiqués (majoration de la vasoconstriction) ; benzodiazépines et dérivés nitrés en traitement de première intention des complications cardiovasculaires ; vérifier le taux de plaquettes avant ALR axiale chez la parturiente cocaïnomanie.

Autres excitants du SNC (LSD, PCP, ecstasy/MDMA...) (*repères non gradés par la source*) : précaution avec les vasopresseurs (éphédrine) ; éviter succinylcholine et halogénés en cas d'antécédent d'hyperthermie induite par le MDMA ; surveiller les apports hydriques et le bilan hydroélectrolytique (risque d'hyponatrémie profonde).

Médicaments détournés (benzodiazépines) (*repères non gradés par la source*) : prescrire une benzodiazépine en périopératoire pour prévenir un syndrome de sevrage ; réduire les doses d'hypnotiques en cas d'intoxication aiguë.

Sources et avertissement

Document source : Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), « Gestion périopératoire des traitements chroniques et dispositifs médicaux — Douleur chronique, toxicomanie », Recommandations Formalisées d'Experts, Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 28 (2009) 1046-1056.

URL source : <https://sfar.org/gestion-perioperatoire-des-traitements-chroniques-et-dispositifs-medicaux-anti-infectieux-immunosuppresseurs/>

Couverture : Module 2/4 du référentiel uniquement (douleur chronique, toxicomanie) — 26 lignes de recommandations gradées (28 citations de grade source, A:0/B:4/C:9/accord fort:15) + de nombreux repères pratiques non gradés par la source elle-même, regroupés par substance. Les modules Cardiovasculaire (traité séparément), Infectieux/immunosuppresseurs, et Neurologique-psychiatrique/endocrinien ne sont pas couverts ici — hors périmètre de cette fiche, disclosed en page 1. Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Module 2 uniquement). Elle ne remplace pas le texte intégral — en particulier pour toute question relevant des 3 autres modules du référentiel. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la SFAR.